

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Université de Constantine 3

Faculté de médecine CHU de Constantine

Laboratoire d'Anatomie

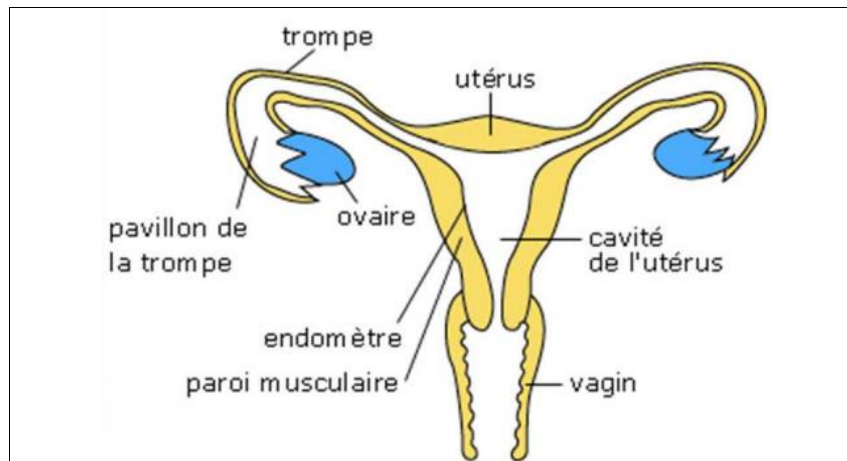
Cours pour étudiants de deuxième année de médecine

Elaboré par le Dr DOUS SAID

UTERUS

I/INTRODUCTION :

L'utérus est un organe creux, musculaire et contractile, dont la fonction essentielle intervient au moment de la gestation pendant laquelle ses modifications sont très importantes ; en effet il reçoit l'œuf fécondé, sert de support nourricier pendant la gestation, et contribue par ses contractions à l'expulsion à terme.



II/ANATOMIE DESCRIPTIVE :

1/SITUATION :

C'est un organe impair et médian, il est situé dans la partie moyenne du petit bassin, entre la vessie en avant, le rectum en arrière, le vagin et le périnée en bas, la cavité abdominale en haut.

2/MORPHOLOGIE EXTERNE :

Elle peut être visualisée par la coelioscopie

a/ Configuration externe :

Il a la forme d'un cône à sommet tronqué, aplati d'avant en arrière, présentant trois parties :

- Le corps : comportant :
 - ✓ Une face vésicale (antéro-inférieure).
 - ✓ Une face intestinale (postéro-supérieure).
 - ✓ Deux bords latéraux épais et mousses.
 - ✓ Un bord supérieur : le fond utérin.
 - ✓ Deux angles latéraux : les cornes utérines où s'abouchent les trompes utérines et où s'insèrent les ligaments ronds et les ligaments propres de l'ovaire.

- Le col : plus étroit, a peu près cylindrique, il donne insertion au vagin qui le divise en trois portions : sus-vaginale, vaginale et sous-vaginale.

Le vagin s'insère sur la portion vaginale selon un plan oblique en bas et en avant. La portion intra-vaginale est donc plus longue en arrière qu'en avant, elle est accessible au toucher vaginal et visualisable par le spéculum, elle a la forme d'un cône tronqué percé à son sommet d'un orifice : l'orifice externe du col qui donne accès à la cavité utérine.

- L'isthme : est situé à la jonction entre le corps et le col, il devient le segment inférieur au cours de la grossesse.

b/ Orientation :

Le point de jonction des axes du col et du corps est extrêmement fixe et correspond au centre du pelvis.

L'antéversion : l'axe d'ensemble de l'utérus forme avec l'axe du vagin un angle ouvert en bas et en avant.

L'antéflexion : l'axe du corps de l'utérus forme avec l'axe du col de l'utérus un angle de 120 degrés, ouvert en bas et en avant.

Le corps utérin est donc en position antéversée, antéfléchie.

c/ Dimensions :

Chez la nullipare : longueur : 6 - 7 cm, largeur : 3 - 5 cm, épaisseur : 2 - 3 cm.

Chez la multipare les dimensions du corps augmentent.

d/ Configuration interne :

Elle peut être étudiée par l'hystérogaphie et l'hystéroscopie.

C'est un organe creux à cavité virtuelle, grossièrement aplati d'avant en arrière et présentant un étranglement correspondant à l'isthme.

La cavité du corps est triangulaire à sommet inférieur. Aux deux angles latéraux s'ouvrent les orifices des trompes utérines.

La cavité du col est fusiforme, mettant en rapport cavités utérine et vaginale, elle présente sur ses parois des plis : les plis palmés (arbre de vie).

e/ Structure :

La paroi utérine, épaisse et résistante comporte trois tuniques :

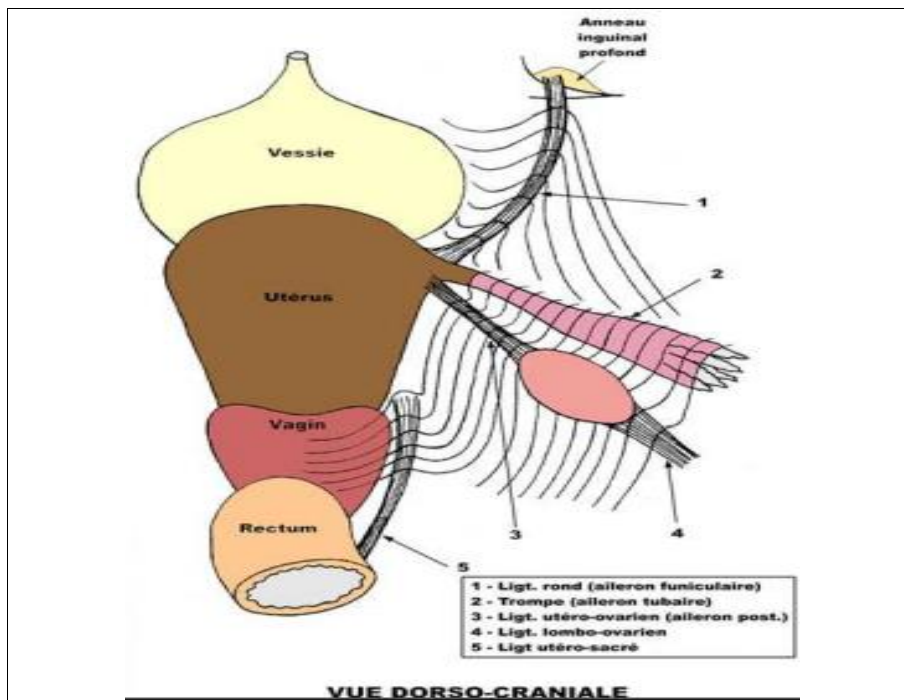
- ✓ La séreuse : péritoine.
- ✓ La musculuse : avec trois couches : interne mince, moyenne très épaisse et richement vascularisée, externe mince.
- ✓ La muqueuse : de type glandulaire au niveau du corps constituant l'endomètre avec deux couches : basale et superficielle : couche fonctionnelle se modifiant au cours du cycle menstruel.
 - Au niveau du col elle présente deux zones :
 - sur l'endocol (canal cervical) elle garde une structure glandulaire.
 - sur l'exocol, au niveau du segment intra vaginal du col elle a la même structure que la muqueuse vaginale (épithélium pavimenteux).

f/ Moyens de fixité :

Trois ligaments maintiennent en place l'utérus

- **Les ligaments larges** : ce sont deux lames péritonéales (double feuillet) transversales tendues de l'utérus à la paroi latérale du petit bassin, ils contiennent les vaisseaux destinés à l'utérus et l'ovaire et la plus grande partie des annexes génitales. De plus leur base repose sur un tissu fibro-musculaire dense : le paramètre.
- **Les ligaments ronds** : nés du versant antérieur des cornes utérines, se dirigent en avant et latéralement, traversent le canal inguinal pour se terminer dans le tissu cellulaire des grandes lèvres.
- **Les ligaments utéro-sacrés** : nés de la face postérieure de l'isthme de l'utérus et se terminent sur la face antérieure du sacrum.
- La pression qu'exercent les organes abdominaux.
- Le col est très fixe par rapport au corps utérin qui est mobile, il est maintenu fixe par :

- Les paramètres : situés de chaque côté de la partie sus-vaginale, constitués par un tissu fibro-cellulaire dense, contenant des fibres musculaires lisses.
- Le vagin : inséré sur le col selon un plan oblique en bas et en avant, le col s'appuie ainsi sur la paroi postérieure du vagin.



III/ RAPPORTS :

1/PORTION SUS-VAGINALE :

- Rapports péritonéaux :

La portion sus-vaginale est partiellement recouverte de péritoine qui tapisse :

- le fond utérin.
- la totalité de la face postérieure.
- la portion supérieure de la face antérieure, le péritoine se réfléchissant en regard de l'isthme.

Les feuillets péritonéaux se continuent :

- Latéralement vers la paroi pelvienne constituant les ligaments larges.
- En avant avec le péritoine vésical dessinant le cul de sac vésico-utérin.
- En arrière avec le péritoine tapissant la face antérieure du vagin avant de se réfléchir sur la face antérieure du rectum dessinant le cul de sac recto-génital (de DOUGLAS).

- Rapports par l'intermédiaire du péritoine :

➤ latéralement :

- les ligaments larges.
- les paramètres : livrant passage à :
 - L'uretère.
 - L'artère utérine croisant l'uretère par en avant.
 - L'artère vaginale croisant par en arrière l'uretère.
 - Veines et lymphatiques.

➤ en avant : la vessie.

➤ en arrière : l'ampoule rectale.

2/ PORTION INTRA-VAGINALE :

Latéralement :

- la partie inférieure des paramètres.
- les lames sacro-recto-génito-pubiennes.

En avant : a la face postérieure de la vessie par l'intermédiaire du septum vésico-vaginal.

En arrière a la face antérieure du rectum par l'intermédiaire du cul de sac recto-génital en haut et le septum recto-vaginal en bas.

VI/ VASCULARISATION ET INNERVATION :

1/ LES ARTERES :

- **L'artère utérine** : elle naît du tronc antérieur de l'artère iliaque interne, longue de 15 cm et présente trois segments, rétro, sous et intra-ligamentaires (ligament large). Se termine au niveau de l'angle supéro-latéral de l'utérus en se divisant en trois branches terminales :

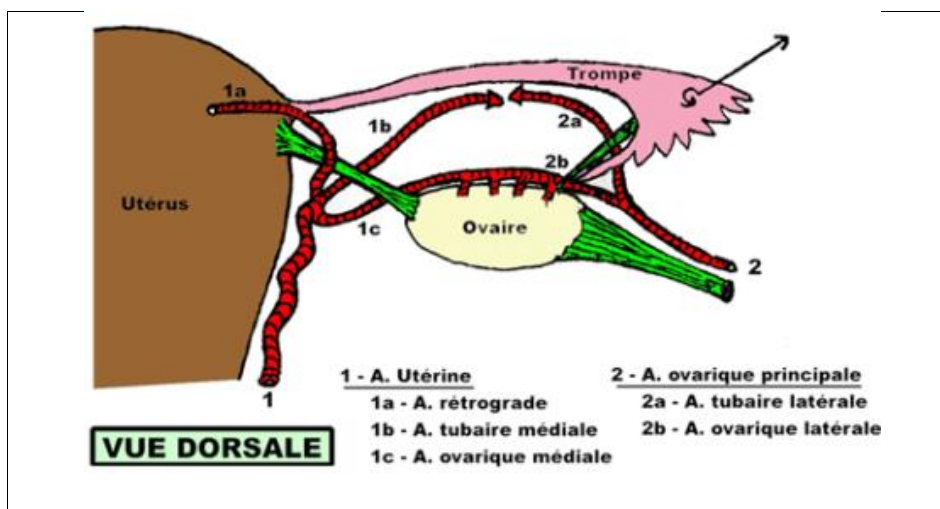
- Rameau récurrent du fond utérin
- Rameau tubaire (artère tubaire médiale)
- Rameau ovarique (artère ovarique médiale)

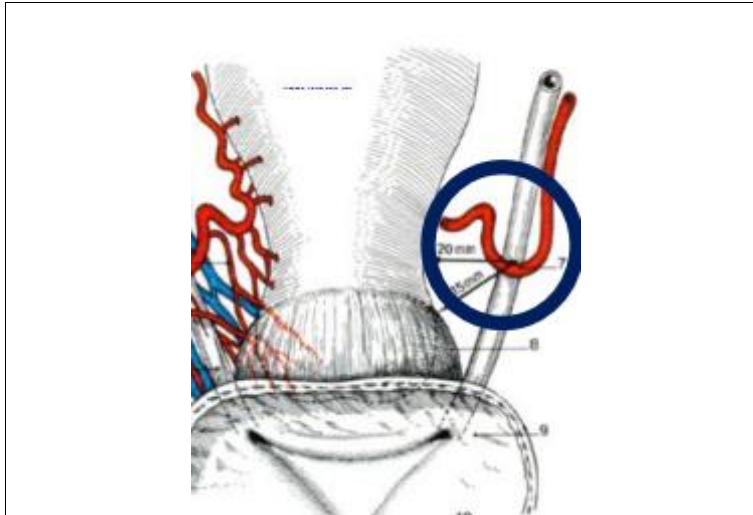
Dans son trajet l'artère utérine donne les collatérales suivantes :

- Rameau pour le ligament large.
- Rameau urétéral.
- 5 à 6 rameaux vésico-génitaux.
- L'artère cervico-vaginale.
- 5 à 6 rameaux pour le col utérin.
- 8 à 10 rameaux pour le corps utérin.

- **L'artère ovarique** : elle naît de l'aorte abdominale à hauteur de L2, se termine à l'extrémité supéro-latérale de l'ovaire en donnant deux rameaux :

- Ovarique latéral qui s'anastomose avec l'artère ovarique médiale branche de l'artère utérine.
 - Tubaire latéral qui s'anastomose avec l'artère tubaire médiale branche de l'artère utérine.
- **L'artère du ligament rond** : branche de l'artère épigastrique inférieure.





Croisement artère utérine et uretère

2/ LES VEINES : satellites des artères

3/ LES LYMPHATIQUES :

Sont formées de quatre réseaux d'origine : muqueux, musculaire, sous-séreux et séreux. Ils se drainent dans deux réseaux de drainage :

- ✓ Réseau supérieur drainant plus particulièrement le corps, avec trois pédicules :
 - Pédicule ovarique :
 - À gauche aux nœuds lymphatiques lombaires pré et latéro-aortiques
 - À droite aux nœuds lymphatiques lombaires pré et latéro-caves
 - Pédicule iliaque interne.
 - Pédicule antérieur, satellite du ligament rond, aboutissant aux nœuds inguinaux superficiels.
- ✓ Réseau inférieur drainant plus particulièrement le col et l'isthme, avec trois pédicules :
 - iliaque externe.
 - iliaque interne.
 - Antéro-postérieur : qui suit le ligament utéro-sacré, se termine dans les nœuds lymphatiques sacrés.

4/ LES NERFS : issus du plexus hypogastrique inférieur et constitue deux pédicules :

- Pédicule cervico- isthmique.
- Pédicule corporéal.

LES TROMPES UTERINES

I-INTRODUCTION

Les trompes utérines sont deux conduit musculo-membraneux pairs et symétriques. Allongées depuis l'ovaire jusqu'à l'angle supéro-latéral de l'utérus. Faisant communiquer la cavité péritonéale et la cavité utérine. Leurs rôles c'est de capter l'ovocyte après ovulation et assurer le transport de l'ovule fécondé vers l'utérus.

II-ANATOMIE DESCRIPTIVE

1-Situation

Les trompes sont situées dans le petit bassin, de part et d'autre de l'utérus. Dans la portion supérieure du ligament large (mésosalpinx).

2-Configuration extérieure

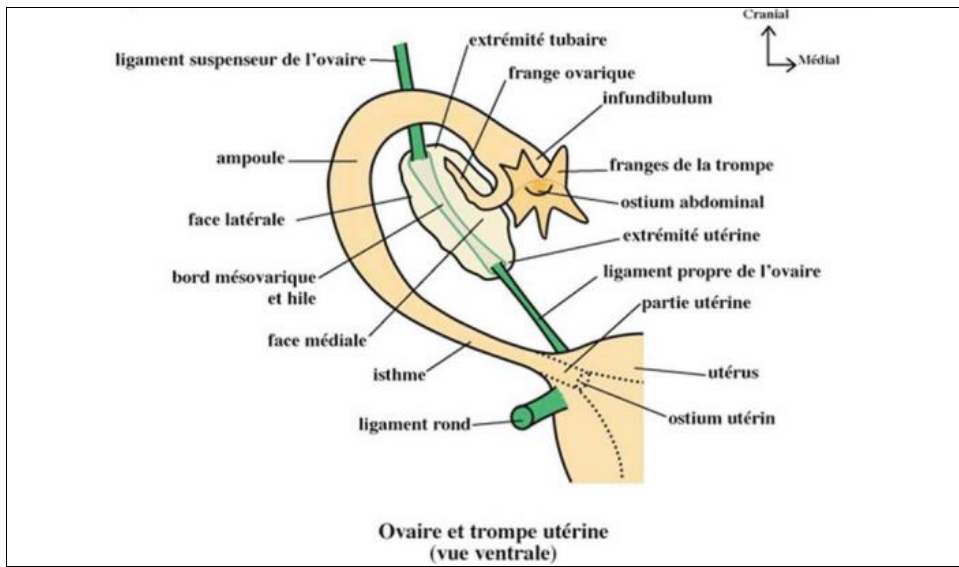
La trompe est un conduit souple, de couleur rouge foncé, d'aspect très vascularisé et de consistance molle. Présente à décrire quatre segments :

a-L'infundibulum ou le pavillon de la trompe: c'est le plus externe, le plus mobile, long de 2-3cm. Il a la forme évasée en entonnoir à contours festonnés formant les franges tubaires, dont la plus longue: frange de Richard . Présente au niveau de son centre un orifice c'est l'ostium abdominal de la trompe.

b-L'ampoule de la trompe: segment souple, il décrit une courbe concave en bas. Long de 7-8cm.

c-L'isthme de la trompe: un conduit à paroi épaisse et rigide. Long de 3-4cm, de faible calibre.

d-Segment utérin (segment interstitiel) : segment cylindrique compris dans la paroi utérine. Long de 1cm. S'ouvre dans la cavité utérine par l'ostium utérin.



3-Fixités

La trompe est très mobile, fixé seulement par :

- Sa partie utérine.
- Le ligament tubo-ovarien.
- Le mésosalpinx : repli péritonéal entourant la trompe (partie supérieure de ligament large).

III- VASCULARISATION

A/ Les artères : La trompe est vascularisée par deux artères qui sont :

- 1- L'artère ovarique : par son rameau tubaire latéral.
- 2- L'artère utérine : par son rameau tubaire médial.

Elles s'anastomosent entre elles constituant une arcade sous-tubaire d'où naissent perpendiculairement, des rameaux pour la trompe.

B/ Les veines : Se drainent dans une volumineuse arcade sous-tubaire (satellite de l'arcade artérielle).

C/ Les lymphatiques : rejoignent les lymphatiques de l'utérus et de l'ovaire.

VI-INNervation : les nerfs proviennent du plexus hypogastrique.

fin